



躯体症状及相关障碍概述

作者: **Joel E. Dimsdale, MD**, University of California, San Diego

Reviewed By **Mark Zimmerman, MD**, South County Psychiatry

已审核/已修订 7月 2024

躯体症状及相关障碍是以过度强烈地关注身体（躯体）症状为特征的精神疾病，这种关注给患者导致强烈痛苦和/或干扰日常功能。

大多数精神疾病以精神健康症状为特征性表现。也即，患者存在异常的或令其苦恼的想法、情绪和/或行为。然而在躯体症状障碍中，精神因素表现为身体症状（这个过程称为躯体化），患者的主要担忧是躯体症状，如疼痛、无力、疲倦、恶心或其他躯体感觉。患者可能存在导致或促发这些症状的躯体疾病，也可能不存在。不过，即使存在躯体疾病，躯体症状障碍患者或相关疾病患者对疾病的反应也属过度。

对身体症状产生情绪反应并不少见。但是，有躯体症状障碍的人会对其症状出现异常强烈的想法、感受和行为反应。这种异常反应与正常反应的区别在于，它强烈到足以对患者（有时也对其他人）造成严重痛苦和/或导致其难以进行日常生活。

在标准精神疾病诊断手册中，患者的反应类型决定了他们的障碍类型，具体见下：

- 在躯体症状障碍中，患者的症状使其担忧和过分关注，令其时刻担心，并/或驱使他们频繁就医。
- 在疾病焦虑障碍（旧称“疑病症”）中，患者过度专注于和担忧自己有可能患有或患上了一种重症疾病。
- 在功能性神经症状障碍（旧称“转换障碍”）中，患者出现类似神经系统症状的躯体症状。
- 有时候，患者的态度或行为可对其患有的躯体疾病产生不良影响——这被称为影响其他病况的心理因素。
- 在做作性障碍中（强加于自己或他人），患者假装自己或他人有症状，即使没有明显的外部获益（例如休假）

由于存在这些障碍的人认为自己的症状是躯体疾病症状，所以他们往往去看常规医生而不是精神保健专业人员。

躯体化症状或相关疾病也可能发生于儿童。

治疗因障碍类型而异，但通常都包含心理治疗。



身心如何相互作用影响健康一直是人们长期讨论的问题。虽然在人们的日常话语中，心与身似乎是两个截然不同的东西，但实际上它们存在非常密切的关联，以至于难以区分它们的作用，比如：

- 社会和心理应激可使躯体疾病症状加重，如糖尿病、冠状动脉疾病和哮喘等。
- 应激和其他心理过程可加重或延长躯体症状。例如，抑郁或焦虑的人在患病或受伤时比心理正常的人遭受更多痛苦。
- 当没有躯体疾病存在时，应激有时也可导致躯体症状。例如，儿童害怕上学时会出现腹痛或恶心症状，或者成人在精神紧张时会出现头痛症状。
- 思想和想法可影响疾病的进展。例如，高血压患者可以否认患病或否认疾病很严重。否认可帮助他们减轻痛苦，但也可妨碍他们遵循治疗方案。例如高血压患者拒绝用药而使病情加重。
- 躯体疾病可影响或导致精神问题。例如，那些患有危及生命的，反复发作的，或慢性疾病的患者通常很抑郁。而抑郁反过来又会加重躯体疾病。
- 脑部疾病，如阿尔茨海默病，可能影响患者的人格和/或清晰思考的能力。

当躯体症状是由应激或心理因素导致时，医生可能难以确定病因。医生可能需要做各种诊断性检查来弄清情况。